

综合护理干预在慢性盆腔炎护理中的应用效果分析与探讨

李娟

永清县人民医院, 河北 廊坊 065600

摘要: 目的: 分析综合护理干预在慢性盆腔炎护理中的应用效果。方法: 本研究选取 2022 年 9 月至 2024 年 9 月期间在我院就诊的 50 例慢性盆腔炎患者作为样本, 通过随机数字表法将其均分为两组, 每组各 25 例。对照组患者接受标准护理方案, 包括药物指导、病情监测、基础生活照料及常规健康宣教; 观察组则在常规护理基础上增加系统性护理干预措施, 具体包含心理疏导、膳食指导、运动管理、多元化健康教育以及康复指导等多项内容。通过比较两组患者治疗后症状缓解程度、生活质量指标(采用 SF-36 量表评估)及对护理服务的满意程度。结果: 观察组症状改善总有效率明显优于对照组 ($P<0.05$); 在 SF-36 量表的 8 个评估维度上, 观察组得分均显著高于对照组 ($P<0.05$); 观察组对护理服务的满意度也明显高于对照组 ($P<0.05$)。结论: 系统性护理干预在慢性盆腔炎治疗过程中能够显著缓解临床症状, 提高患者生活质量和护理满意度, 值得在临床实践中推广应用。

关键词: 综合护理干预; 慢性盆腔炎护理; 应用效果; 探讨

引言

慢性盆腔炎(Chronic Pelvic Inflammatory Disease, CPID)是妇科临床常见的一种慢性炎症性疾病, 其发病机制较为复杂, 多数情况下是由于急性盆腔炎没有得到彻底的治疗, 病原体持续感染, 或者患者的自身免疫功能较弱, 使得病程迁延所致。根据流行病学调查数据显示, 全球范围内育龄期女性慢性盆腔炎的发病率大约在 15%-20%之间, 并且近年来有年轻化的趋势。慢性盆腔炎的主要临床表现是持续性下腹部坠胀、疼痛以及腰骶部酸痛, 伴随着月经紊乱、白带异常等症状, 严重的甚至会引起盆腔粘连、输卵管堵塞等情况, 从而导致不孕症、异位妊娠等并发症的发生。综合护理干预属于现代护理理念的重要实践形式, 重视以患者为中心, 涵盖心理护理, 健康教育, 康复指导等多方面护理手段, 目标是通过系统而个性化的护理服务来改善患者的身心状况, 增进患者的治疗顺从度以及康复效果。近些年来, 综合护理干预在诸多慢性病管理当中显示出明显的优势, 不过在慢性盆腔炎护理方面的应用研究仍旧处在探寻的阶段。鉴于此, 本项研究借助对比常规护理与综合护理干预在慢性盆腔炎患者中的应用情况, 希望给改良临床护理计划, 改进护理服务品质给予科学的参照。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究选取 2022 年 9 月至 2024 年 9 月期间在我院就诊的 50 例慢性盆腔炎患者作为分析样本。研究对象筛选依据如下: 符合《妇产科学》关于慢性盆腔炎的临床诊断标准; 年龄范围限定在 18-55 周岁; 所有参与者均签署知情同意书。排除条件包括: 合并严重心肝肾等器官功能障碍; 存在精神疾病史; 近期接受过可能干扰研究结果的其它治疗措施。通过随机数字分配方法将受试者均分为观察组和对照组各 25 例。观察组年龄分布 20-53 岁, 平均 (35.64 ± 5.23) 岁; 病程 1-5 年, 平均 (2.82 ± 0.75) 年。对照组年龄范围 18-55 岁, 平均 (36.23 ± 4.82) 岁; 病程 1-6 年, 平均 (3.04 ± 0.83) 年。两组在基线资料方面无显著统计学差异 ($P>0.05$), 具备良好的可比性。

1.2 方法

对照组行常规护理, 遵医嘱用药、病情观察、基础生活护理、健康教育(发放宣传资料、口头讲解疾病知识)。

观察组在常规护理基础上实施综合护理干预, 具体如下
心理护理: 慢性盆腔炎病程长, 易复发, 患者常有焦虑、抑郁等不良情绪, 这些不良情绪会影响患者的治疗依从性和康复效果, 护理人员积极主动地与患者沟通交流, 耐心倾听患者的倾诉, 了解患者的心理状况和需求, 用通俗易懂的语言向患者介绍疾病的起因、发展、治疗和预后等情况, 使患者正确对待疾病, 消除患者的恐惧和疑虑心理, 并向患者介绍成功的治愈案例, 提高患者战胜疾病的信心。每周至少与患者沟通 2 次, 每次沟通时间不少于 20 分钟。

饮食护理: 针对患者的病情和营养状况, 给患者拟定恰当的饮食计划, 告诉患者多吃高蛋白, 高维生素, 容易吸收的食物, 像瘦肉, 鱼, 蛋, 新鲜蔬菜, 水果之类, 来加强身体的抵抗能力, 不要吃辣, 油腻, 刺激性的食物。

运动护理: 根据患者的体质以及兴趣爱好, 指导患者选择适合的运动方式, 比如散步、瑜伽、太极拳等, 运动强度以患者不感到疲劳为准, 建议患者每周运动 3-5 次, 每次运动 30-60 分钟, 运动时护理人员要密切观察患者的反应, 保证运动的安全性, 通过运动促进患者的盆腔血液循环, 改善组织营养状态, 提高新陈代谢, 利于炎症的吸收和消退。

健康教育: 常规的健康教育之外, 还有多样的形式, 比如开办健康讲座, 播放视频材料, 创建微信群做线上健康指导之类的, 定期组织病人参与健康讲座, 主要讲解关于慢性盆腔炎方面的病因、症状、治疗手段、防治措施以及日常生活的注意事项等内容。

康复护理: 指导患者进行盆腔康复训练, 如盆底肌锻炼, 患者取仰卧位, 双膝屈曲, 放松腹部肌肉, 收缩肛门及阴道周围肌肉, 持续 3-5 秒, 然后放松, 反复进行 10-15 次为一组, 每天进行 3-4 组, 通过盆底肌锻炼, 增强盆底肌肉力量, 改善盆腔血液循环, 促进炎症吸收, 对于腹部疼痛明显的患者, 可采用热敷的方法, 用热水袋或热毛巾敷于下腹部, 温度以患者能耐受为宜, 每次热敷 15-20 分钟, 每天热敷 2-3

表1 比较2组患者的生活质量的评分 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	躯体健康		心理健康		物质生活		社会功能	
		护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
对照组	25	74.32 $\pm$ 7.21	80.75 $\pm$ 7.91	73.24 $\pm$ 7.81	70.38 $\pm$ 6.91	73.35 $\pm$ 8.21	79.43 $\pm$ 8.34	69.35 $\pm$ 7.13	75.34 $\pm$ 7.43
观察组	25	74.65 $\pm$ 7.54	89.43 $\pm$ 8.02	73.41 $\pm$ 8.12	84.53 $\pm$ 7.32	72.95 $\pm$ 7.98	88.14 $\pm$ 9.37	69.45 $\pm$ 7.61	85.43 $\pm$ 8.04
t		0.1582	3.8528	0.0754	7.0284	0.1747	3.4718	0.0479	4.6084
P		0.8750	0.0003	0.9402	0.0000	0.8621	0.0011	0.9620	0.0000

次,以缓解疼痛。

1.3 观察指标

临床症状改善评估:对比两组患者经治疗后下腹胀感、疼痛程度及腰骶区域酸胀不适等临床表现的变化趋势。症状缓解程度划分为显著缓解、部分缓解、未缓解三个层级。显著缓解指症状完全消除;部分缓解指症状明显减轻;未缓解指症状持续存在或加重。总体缓解率=(显著缓解病例数+部分缓解病例数)/总病例数 $\times$ 100%。

生存质量测评:运用SF-36健康调查量表对两组患者治疗后的生活品质进行量化评估,该量表涵盖身体机能、日常活动能力、躯体不适感、总体健康状态、活力水平、社交能力、情绪状态、心理健康状况8个评估维度,各维度评分范围为0-100分,分值越高代表生存质量越佳。

护理满意度评估:运用本院专门设计的满意度测评量表对住院患者展开调研,该量表涵盖护理人员服务态度、专业技能水平、健康宣教成效及心理疏导质量等维度,采用三级评分制(高度满意、基本满意、不满意)。满意度计算公式为:(高度满意病例数+基本满意病例数)/总调查人数 $\times$ 100%。

1.4 统计学方法

将本组数据代入SPSS21.0软件处理分析,计量资料用($\bar{x} \pm s$)表示,实施t检验;计数资料用%表示,用 χ^2 检验。 $P < 0.05$,差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 比较2组患者的生活质量的评分

通过对对照组与观察组中患者生活质量的评分进行比较,观察组要优于对照组, $P < 0.05$,差异具有统计学意义。具体结果见表1。

2.2 两组患者护理满意度比较

观察组患者护理满意度显著高于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),详见表2。

表2 两组患者护理满意度比较 (n, %)

组别	例数	非常满意	满意	不满意	满意度
观察组	25	14	10	1	24 (97.50%)
对照组	25	10	5	10	15 (60.00%)
χ^2					9.4406
P					0.0021

2.3 两组患者临床症状改善情况比较

观察组患者临床症状改善总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义($P < 0.05$),详见表3。

表3 两组患者临床症状改善情况比较 (n, %)

组别	例数	显效	有效	无效	有效率
观察组	25	19	4	2	23 (92.00%)
对照组	25	12	4	9	16 (64.00%)
χ^2					5.7110
P					0.0168

3 讨论

慢性盆腔炎是妇科中比较常见的一种慢性疾病,治疗时间长、易反复发,给患者带来生理和心理上的痛苦。常规护理虽能满足患者治疗及生活的需要,但是不能对患者的心理、饮食、运动等方面做全面的护理和指导,不能真正改善患者的生活质量和治疗效果。在本研究中,观察组除了常规护理外,还进行综合护理,从心理、饮食、运动、健康教育、康复等各方面给予患者全方位的护理。心理方面,通过与患者沟通交流,帮助患者消除或缓解各种不良情绪,增强了患者战胜疾病的自信心,提高了患者的治疗依从性。研究发现,良好的心理状态有利于提高机体的免疫能力,促进疾病的康复。饮食护理为患者提供个体化饮食护理,确保患者摄取足够的营养,增强患者免疫力的同时不会产生不良饮食习惯对疾病的不良影响。运动护理指导患者适当运动,增强盆腔血液循环,促进组织营养吸收,有利于炎症的吸收。多样化的健康宣教形式让患者对疾病知识有更全面、更深刻的了解,增强了患者的自我保健意识和能力。康复护理中的盆腔康复锻炼、热敷等护理措施直接作用于病灶处,减轻患者的疼痛等症状。从研究结果可以看出,观察组患者临床症状改善总有效率,生活质素得分以及护理满意度均高于对照组,从而证明综合护理干预可以有效改善慢性盆腔炎患者的临床症状,提升患者的生活质量,并且也得到了患者的好评^[8]。综合护理干预打破了以往护理干预的模式,将多种护理措施相结合,形成了一个全面、综合、个体化护理系统,更能满足患者的需求,促进其康复。

4 结束语

综上所述,综合护理干预于慢性盆腔炎护理里有着明显的效果,可以改善患者的临床症状,提升患者的生活质量与护理满意程度,在护理工作中,要大力推行综合护理干预模式,给慢性盆腔炎患者赋予更为优质、完备的护理服务,帮

助他们尽快康复，不过，这个研究的样本数量偏少，研究历时较短，或许会有某些局限性。

参考文献：

[1] 马璐. 中医护理干预在慢性盆腔炎护理中的应用价值[J]. 健康之友, 2021 (4): 217.

[2] 杨苗苗. 健康教育在慢性盆腔炎护理中的应用效果[J]. 妇儿健康导刊, 2023, 2 (24): 176-178.

[3] 李光青. 加强健康宣教在慢性盆腔炎护理中的应用

[J]. 妇儿健康导刊, 2024, 3 (1): 170-173.

[4] 姜路艳. 心理应激对策在慢性盆腔炎护理中的应用效果[J]. 妇儿健康导刊, 2024, 3 (5): 147-149, 156.

[5] 于晶. 针对性护理干预在慢性盆腔炎护理中的应用效果[J]. 我和宝贝, 2021, 11 (10): 50-51.

[6] 王梅兰. 综合护理干预在慢性盆腔炎护理中的应用价值研究[J]. 中国保健营养, 2021, 31 (28): 126.